HOSPITAL GENERAL DE CASTELLON

Servicio de RADIOLOGIA GENERAL

Servicio peticionario / Servei peticionari

Sección peticionaria / Secció peticionaria

Médico peticionario / Metge peticionari

Diagnóstico / Diagnòstic

Situación / Situació: Ambulatorio

Cama / Llit

NHC

SIP

Núm. de informe / *Núm. d'informe*

Primer apellido / Primer cognom

Segundo apellido / Segon cognom

Nombre / Nom

Fecha de nacimiento / Data de naixement

Sexo / Sexe: Mujer

Informe de prueba diagnóstica / Informe de prova diagnòstica

Datos clínicos / Dades clíniques

Exploraciones informadas / Exploracions informades

12/05/2017 09:19 TC TÓRAX, SIN/CON CONTRASTE

Valoración / Valoració

Datos clínicos: Embolismo pulmonar diagnosticado en noviembre de 2016. Antecedentes de TBC en infancia con paquipleuritis derecha residual.
Informe radiológico:
Se realiza TAC torácico tras administración de CIV.
Tractos engrosados apicales bilaterales, compatibles con cambios post TBC.
Elevación diafragmática derecha, debido probablemente a una relajación diafragmática,ya que se observa una la elevación del diafragma en toda su extensión.
No hay signos radiológicos de paquipleuritis ni de otros cambios post tuberculosos excepto los ya descritos.
Se observa un pequeño defecto de repleción en la arteria pulmonar derecha, sugestivo de tratarse de restos de su embolismo previo, habiéndose convertido en un tromboembolismo cronico.
No hay cardiomegalia.
Llama la atención un bocio endotorácico a expensas del LTI que tiene unas medidas de 3 x 3 x 5 cm de ejes máximos, llegando la porción endotorácica hasta la altura de la salida de los troncos supraaórticos.
Como hallazgo incidental se observa una imagen de atrofia del polo inferior del riñón derecho, debido probablemente a un infarto isquémico.
Resto sin hallazgos.

Anexos:

Autores / Autors

Fdo./Signat MARCO DOMENECH, SANTIAGO

MÉDICO RADIÓLOGO

15/05/2017